

O SENTIDO DA VIDA EXPLICADO

*uma leitura definitiva sobre a Logoterapia
de Viktor Frankl*

ITALO MARSILI

Edições Mar Atlântico

© Italo Marsili
Edições Mar Atlântico

ISBN: _____

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou meio sem autorização prévia e escrita do autor.

EPÍGRAFE

“Em vez de dissolver a individualidade humana nos seus elementos, mediante análises tediosas que arriscam perder-se em detalhes irrelevantes, a logoterapia busca consolidar e fixar o paciente, de imediato, no ponto central do seu ser, que é, e não por coincidência, também o ponto mais alto. Eis aí por que é inútil buscar provas teóricas do sentido da vida: ele não é uma máxima uniforme, válida para todos – é a obrigação imanente que cada um tem de transcender-se. Discutir o sentido da vida sem realizá-lo seria negá-lo; e, uma vez que começamos a realizá-lo, já não é preciso discuti-lo, porque ele se impõe com uma evidência que até a mente mais cínica se envergonharia de negar”.

-- Olavo de Carvalho

Sumário

Introdução	1
PARTE I.....	7
A terceira dimensão	9
Person e Charakter	47
Autodistanciamento	85
Autotranscendência	123
A potência rebelde do espírito.....	161
PARTE II	199
A vontade de sentido	201
A liberdade de atitude	239
A consciência como órgão do sentido	277
A objetividade do sentido.....	313
O vazio existencial.....	351
A neurose noogênica.....	389
PARTE III.....	427
Os três caminhos do sentido	429
A tríade trágica	465
O sofrimento	501
O amor	535
A morte e a transitoriedade.....	563
O Über-Sinn	597

PARTE IV.....	631
A antropologia declarada.....	633
A antropologia operante.....	675
O que o sistema acertou	713
O que falta	747
A teologia suspensa	773
PARTE V	797
O lugar de Frankl.....	799
O que ficou por fazer.....	823
Uma clínica do sentido	841
Glossário.....	857

Introdução

É comum que a vida de homens realmente grandes seja aquilo que mais se conhece da sua obra, e que a obra técnica, por um efeito que a admiração produz nos que a recebem, acabe relegada a uma espécie de segundo plano honroso — consultada por obrigação, citada por fragmentos, mas nunca percorrida com o mesmo interesse que se dedica à biografia. Há nisto um mecanismo que não costuma ser examinado e que, se o fosse, revelaria algo sobre a natureza da recepção intelectual em geral: o temor de que a análise rigorosa da obra exponha lacunas que os admiradores preferem não ver, porque supõem, sem razão, que uma lacuna no sistema equivalha a uma mancha na vida do autor. O resultado é uma forma singular de proteção, que sob a aparência do respeito opera como negligência — a obra é venerada na mesma medida em que é dispensada de exame.

Com Viktor Frankl esse fenômeno atingiu uma configuração própria. A vida é conhecida em detalhe: os campos, as perdas, o casaco trocado, o manuscrito costurado no forro, a frase sobre a última liberdade que resta ao homem quando tudo o mais lhe foi tirado. Os adeptos da logoterapia sabem recontar cada episódio com a fluência de quem já os repetiu dezenas de vezes, e essa fluência é real — o testemunho de Frankl possui uma força que dispensa comentário. O que a fluência encobre, porém, é a extensão do desconhecimento que existe sobre a obra propriamente técnica, aquela que Frankl escreveu ao longo de seis décadas em volumes que não se destinavam ao grande público e que exigem, da parte de quem os lê, familiaridade com distinções que o testemunho não

contém. Peça-se a um defensor habitual da logoterapia que explique em que consiste o antagonismo noopsíquico facultativo, tal como aparece em *El Hombre Doliente*, ou que desenvolva o conceito de neuroses coletivas — as quase-neuroses civilizacionais que Frankl distingue com cuidado das neuroses clínicas em *On the Theory and Therapy of Mental Disorders* —, ou que descreva a função das hipercompreensões noopsíquicas na dinâmica do neurótico compulsivo, conforme exposta em *Psicoterapia e Sentido da Vida*, e o silêncio será quase total. Estes conceitos existem. Foram publicados. Pertencem ao corpo da obra tanto quanto a vontade de sentido ou a tríade trágica. Mas o testemunho os absorveu, ou antes, a celebração do testemunho produziu uma condição em que a obra clínica e filosófica sobrevive sem leitores atentos, protegida pela mesma veneração que a impede de ser lida com seriedade.

A consequência desta configuração não é apenas cultural, torna-se estrutural. Um sistema de pensamento que não é examinado onde precisa de exame permanece vulnerável às objeções que os seus próprios defensores deveriam ter enfrentado. A logoterapia tem lacunas. Tem pontos onde o argumento flutua sem fundação suficiente, onde a coerência interna exigiria um passo que Frankl indicou mas não deu, onde a terminologia oscila entre registos e a mesma palavra designa coisas distintas em obras diferentes. Nenhuma dessas fragilidades diminui a estatura do que Frankl realizou. Todas elas, porém, precisam de ser identificadas com precisão e, onde possível, resolvidas — porque quem mais se prejudica com uma fundação insuficiente é exactamente quem pretende servir-se dela na prática clínica e na orientação de vidas.

O trabalho que este livro realiza sobre a obra de Frankl parte de uma leitura integral das dezasseis obras que compõem o corpus disponível e acessível para mim, incluindo textos em quatro línguas e volumes que, pelo seu carácter técnico, circulam

apenas entre especialistas. A leitura que fiz ao longo dos últimos doze anos foi conduzida com a mesma atenção que se dedicaria a qualquer autor cujo sistema se quisesse compreender por inteiro — o que significa que a generosidade interpretativa e o rigor analítico operam em simultâneo, sem que um dispense o outro. Onde Frankl argumenta com solidez, o argumento é exposto e desenvolvido nos seus próprios termos. Onde o argumento exige uma fundação que Frankl não forneceu, a fundação é proposta. Onde a terminologia gera ambiguidade — e há casos em que o mesmo termo, *análise existencial*, designa tanto o método de Frankl quanto o de Binswanger, sem que a distinção seja feita de modo consistente ao longo das obras —, a ambiguidade é identificada e, quando possível, resolvida.

As fragilidades que o exame revela são de natureza diversa. A mais grave diz respeito ao conceito que sustenta todo o sistema: a dimensão noética, aquela camada do humano que Frankl situa além do biológico e do psicológico, é assumida como dado ontológico sem que se ofereçam critérios que permitam distingui-la operacionalmente das funções psíquicas superiores. O postulado do espírito inleso, segundo o qual mesmo nas psicoses mais severas subsiste um núcleo espiritual intacto capaz de liberdade residual, permanece sustentado por observações clínicas pontuais e não por evidência sistemática. A relação declaradamente neutra da logoterapia com a religião convive, ao longo de toda a obra, com referências recorrentes ao supra-sentido e à presença ignorada de Deus que apontam numa direcção confessional nunca assumida como tal. Cada uma destas questões será examinada no lugar que lhe corresponde. Nenhuma delas é mencionada aqui por gosto de inventário, mas porque a sua existência condiciona a leitura de tudo o que se segue e porque o facto de terem permanecido sem exame durante décadas indica, por si só, a natureza da recepção que a obra de Frankl conheceu até agora.

O que este livro oferece ao logoterapeuta e ao leitor que leva Frankl a sério é aquilo que a veneração impediu: um tratamento da obra que a respeita o suficiente para a submeter ao exame que ela própria solicita. Há conceitos que Frankl formulou com precisão e que resistem intactos a qualquer análise — a vontade de sentido, a ontologia dimensional, a descrição da consciência como órgão do sentido. Há outros que estão na obra sem nome e sem formalização, e que só se tornam visíveis quando o sistema é percorrido na sua totalidade. Há outros ainda que precisam de uma fundação filosófica que Frankl não possuía ou não quis fornecer, e que permanecem, por isso, em estado de suspensão — válidos na intuição, frágeis na justificação. O trabalho de distinguir uns dos outros, de formalizar o que ficou sem nome e de fundar o que permaneceu suspenso, é o trabalho deste livro.

O ponto de partida é o conceito que Frankl colocou no centro do seu sistema e do qual tudo o mais depende: o noético, o estrato do humano que não se reduz ao corpo nem à psique e que Frankl designa, em momentos diferentes da obra, como *Geist*, como *Person*, como o propriamente espiritual. Deste conceito primeiro derivam os que lhe dão operatividade: a autotranscendência, o autodistanciamento, o antagonismo psico-noético — isto é, a capacidade que o espírito tem de se opor às determinações do organismo psicofísico — e a noodinâmica, a tensão saudável entre o que o homem é e o que o sentido lhe pede, desdobramentos que recebem aqui o tratamento que a sua centralidade exige. Desse núcleo procede tudo o que a dimensão noética faz: a liberdade incondicionada de escolher uma atitude mesmo quando as circunstâncias não podem ser alteradas, a vontade de sentido como motivação que antecede e subordina tanto o prazer quanto o poder, e a consciência tal como Frankl a entende — um órgão do sentido, intuitivo e falível, cuja falibilidade mesma constitui o

fundamento da tolerância entre os homens. Quando essa vontade é frustrada, o sistema descreve uma sequência que vai da frustração existencial ao vazio existencial e deste à neurose noogênica — uma sequência que Frankl manteve consistente ao longo de décadas e que este livro reconstrói com fidelidade antes de a submeter a exame.

O que a dimensão noética encontra quando age constitui um terceiro momento do argumento: os valores criativos, vivenciais e atitudinais, os três modos pelos quais Frankl concebe a realização do sentido, e em particular o valor atitudinal, aquele que se realiza perante o sofrimento que já não pode ser suprimido e que Frankl associa à figura do *homo patiens*, o homem que sofre com dignidade e que, ao sofrer assim, realiza o valor mais elevado de que é capaz. A tríade trágica — sofrimento, culpa e morte — e a questão do supra-sentido, o sentido último que excede a capacidade intelectual do homem e ao qual só se acede por um acto de decisão existencial próximo da fé, pertencem a este mesmo momento e abrem as questões que o livro enfrenta na sua fase final. Porque é a partir daqui que a análise se desloca da obra declarada para a obra operante: as estruturas que organizam o pensamento de Frankl sem que ele as tenha nomeado, as matrizes que distribuem os seus conceitos em eixos que a obra pressupõe mas não formaliza, e as insuficiências propriamente ditas — os pontos em que o sistema solicita uma fundação que não recebeu e que, recebendo-a, se tornaria mais coerente do que o seu autor o deixou. A questão do limiar teológico, a tensão entre a neutralidade confessional que Frankl declara e a gravitação para a transcendência que os seus textos documentam, é tratada por último porque só pode ser tratada depois de tudo o resto ter sido examinado — e porque é ali, nesse limiar, que o sistema revela com maior lucidez tanto a sua força quanto o que lhe falta.

O que está em causa neste exame excede o interesse historiográfico ou o mero exercício de comentário. A logoterapia orienta práticas e sustenta decisões clínicas. Informa a maneira como terapeutas compreendem o sofrimento dos seus pacientes e a maneira como esses pacientes são conduzidos — ou não — a uma relação com o sentido da própria existência. Um sistema com este grau de incidência sobre vidas concretas não pode subsistir com fundações que nunca foram testadas, com ambiguidades que nunca foram resolvidas, com pressupostos filosóficos que operam sem serem reconhecidos como tais. A questão não é se Frankl estava certo ou errado — há nele intuições de uma acuidade que poucos autores do século XX alcançaram, e o facto de o seu sistema ter resistido a décadas de aplicação clínica sem revisão de fundo diz algo sobre a robustez do que captou. A questão é que uma intuição, por mais certa que seja, permanece aquém do que se exige de um sistema quando esse sistema pretende orientar a acção de outros. A intuição capta. O sistema precisa de justificar o que a intuição captou, e é nesse intervalo — entre o que Frankl viu e o que Frankl demonstrou — que o presente trabalho se situa.

PARTE I

CAPÍTULO 1

A terceira dimensão

Há uma experiência clínica que precede toda a ontologia dimensional de Viktor Frankl e que, se não for compreendida no seu carácter pré-teórico, impede que se compreenda o que veio depois. A experiência é esta: na prática psiquiátrica quotidiana, diante de pacientes cujo sofrimento se mostrava refractário aos mecanismos orgânicos e às dinâmicas psíquicas conhecidas, Frankl deparou-se com uma resistência — o caso resistia à redução. O paciente apresentava algo que extravasava os instrumentos de que a psiquiatria e a psicologia dispunham, algo que se manifestava nos termos habituais do adoecer e do curar com uma origem estranha à constituição daquelas disciplinas. Aquilo que resistia à explicação biológica e à explicação psicológica era, ao contrário do que a leitura redutora supõe, justamente o que conferia ao fenómeno o seu carácter propriamente humano — e desaparecia no exacto momento em que o olhar clínico o reduzia a um dos dois planos disponíveis.

A constatação tinha consequências. Se o sofrimento de certos pacientes — de um número suficiente para que a observação não pudesse ser descartada como anomalia — possuía uma componente alheia ao somático e ao psíquico, então a imagem do ser humano com que a psiquiatria trabalhava estava incompleta. A imagem que a psicanálise herdara de Freud conhecia duas camadas, a somática e a psíquica, e a relação entre ambas era concebida segundo o modelo do paralelismo psicofísico ou, nas versões mais sofisticadas, segundo o modelo da determinação causal recíproca. Em qualquer dos casos, o ser

humano era compreendido como uma realidade bidimensional — o corpo e a psique, com tudo o que se podia dizer sobre as relações entre os dois. A psicologia individual de Adler deslocara o acento da dinâmica pulsional para a dinâmica social mantendo intacto o quadro bidimensional: o que era explicado por impulsos passava a ser explicado por compensações, por inferioridade sentida e por esforço de superação, tudo ainda no plano do psíquico e das suas determinações. O behaviorismo, por sua vez, dispensara a noção de vida interior e trabalhava apenas com estímulos e respostas observáveis, uma opção que, quanto ao quadro antropológico, reduzia o bidimensional ao unidimensional — o ser humano como organismo que responde.

Em todos estes casos, o que Frankl observava na clínica não tinha lugar. O paciente que sofria por não encontrar sentido para a sua existência, atormentado por uma culpa estranha a qualquer conteúdo reprimido e a qualquer conflito identificável, remetido para a relação com a totalidade da vida vivida, que experimentava um vazio que nenhuma satisfação pulsional suprimia e que nenhuma compensação social aliviava — esse paciente era, nos termos daquelas psicologias, um enigma sem categoria, e o destino mais provável do seu sofrimento era ser reclassificado numa das categorias existentes, o que equivalia a perdê-lo como fenómeno. Reduzir a culpa existencial a culpa neurótica, traduzir a falta de sentido em termos de frustração pulsional, interpretar o vazio como sintoma depressivo — tudo isto era possível nos quadros teóricos vigentes, e em muitos casos era exactamente o que acontecia. O que se perdia com a tradução era o próprio fenómeno: um sofrimento cuja origem residia para além da psique e do corpo, naquilo que o ser humano é enquanto ser que se interroga sobre o sentido do que vive.

Há um caso clínico que Frankl narra em *On the Theory and Therapy of Mental Disorders* e que torna visível a natureza desta perda. Uma paciente idosa, adoecida e consciente de que a fase final da sua vida já não possuía nenhuma das condições que antes a preenchião, comparava a plenitude de sentido dos seus anos anteriores com o vazio do presente e perguntava por que razão haveria de continuar a suportar um sofrimento ao qual já não correspondia nenhum significado. A pergunta era inteligível nos termos de qualquer psicologia — tratava-se, aparentemente, de uma paciente deprimida que avaliava negativamente a sua situação —, e a resposta de Frankl recusou os termos da psicologia convencional. Em vez de abordar a disposição afectiva ou de corrigir a distorção cognitiva, Frankl confrontou a paciente com uma afirmação que, na lógica habitual da terapia, seria incompreensível: disse-lhe que toda a sua vida, incluindo a fase anterior que ela recordava como plena, tinha sido igualmente destituída de sentido, e que a diferença entre as duas fases consistia apenas em que, na primeira, ela ainda estava em condições de acreditar num sentido, ao passo que, na presente, já não o conseguia. A paciente reagiu com perplexidade e com lágrimas — e foi essa reacção que revelou o ponto: a perplexidade e as lágrimas procediam de algo que uma interpretação puramente psicológica não conseguia captar, porque o que ali se jogava era a relação do sujeito inteiro com a questão de saber se a sua existência, tomada como um todo, possuía justificação. A intervenção de Frankl tocava uma dimensão que a nosologia vigente não reconhecia e era exactamente isso que a tornava eficaz.

* * *

A resposta de Frankl a esta situação clínica não consistiu em acrescentar um elemento novo ao quadro existente — um terceiro factor dentro do plano bidimensional que viesse

completar o que faltava. A sua resposta foi de outra ordem: o quadro bidimensional, enquanto bidimensional, era incapaz de receber o fenómeno, porque o fenómeno pertencia a uma dimensão que o quadro, pela sua própria estrutura, excluía. O passo necessário era reconhecer que o ser humano se manifesta em três dimensões ontologicamente distintas — a somática, a psíquica e a noética — e que a relação entre elas é uma relação de dimensões no sentido geométrico do termo, com todas as consequências que daí derivam para a compreensão do que se perde quando uma dimensão superior é projectada num plano inferior.

A palavra noética, que Frankl retira do grego *nous*, designa esta terceira dimensão. Não se trata do espiritual no sentido confessional, embora Frankl nunca tenha conseguido livrar-se inteiramente da ambiguidade que o termo arrasta, e embora essa ambiguidade constitua um dos problemas que o sistema terá de enfrentar. Trata-se, na formulação que Frankl emprega com maior consistência ao longo da obra, da dimensão especificamente humana — aquela em que o ser humano é capaz de se distanciar de si mesmo, de se posicionar em relação ao que lhe acontece, de escolher uma atitude perante condições que não pode alterar, de perguntar pelo sentido do que vive e de se orientar em função da resposta. A dimensão noética é, nos termos de Frankl, aquilo que faz do ser humano um ser humano — aquilo que só nele se verifica e que só nele funciona como instância de decisão perante o conjunto do que é, distinto do corpo que partilha com os outros organismos e da psique que partilha com os outros animais dotados de vida interior.

A formulação é bastante clara e a intuição que a sustenta é clinicamente verificável — qualquer psiquiatra experiente reconhece no consultório a diferença entre um sofrimento que responde à intervenção farmacológica, um sofrimento que responde à intervenção psicoterápica e um sofrimento alheio a

ambas porque a sua origem se situa numa ordem que nem a farmacologia nem a psicoterapia convencionais estão equipadas para abordar. O que essa intuição exige como fundação — a demonstração de que o noético constitui efectivamente uma dimensão ontológica e não uma função psíquica de ordem superior — é uma questão que Frankl não resolve e que constitui a fragilidade mais grave do seu sistema. A descrição fenomenológica, porém, é robusta, e é sobre ela que a ontologia dimensional se apoia.

A formulação mais densa da posição aparece em *Psicoterapia e Existencialismo*, onde Frankl descreve a passagem da dimensão somático-psíquica para a noética como uma elevação que acompanha a liberdade:

O ser humano não é livre de condicionamentos, sejam eles de natureza biológica, psicológica ou sociológica. Mas ele é, e sempre permanece, livre para tomar uma posição diante de tais condicionamentos; ele sempre conserva sua liberdade para escolher sua atitude perante esses condicionamentos. O homem é livre para elevar-se sobre o plano dos determinantes somáticos e psíquicos de sua existência. Do mesmo modo, abre-se aí uma nova dimensão. O ser humano adentra a dimensão noética, que se distingue dos fenômenos somáticos e psíquicos. Ele se torna capaz de tomar uma posição não só diante do mundo exterior mas diante de si mesmo. O homem é um ser capaz de refletir sobre si próprio e, até mesmo, de rejeitar-se. Ele pode ser seu próprio juiz, o juiz de suas próprias ações.

(*Psicoterapia e Existencialismo*, I. Os Fundamentos Filosóficos da Logoterapia)

O que esta passagem articula é a conexão entre liberdade e dimensão noética: o noético é aquilo que, no ser humano, permite que ele se posicione perante aquilo que, nos outros planos, o condiciona. O condicionamento somático é real — a doença, a fadiga, a constituição bioquímica determinam

aspectos da experiência de qualquer pessoa. O condicionamento psíquico é igualmente real — os padrões emocionais, as associações, os mecanismos defensivos funcionam com regularidade suficiente para que a psicologia os possa descrever e prever. O que o noético acrescenta é a possibilidade de que o sujeito desses condicionamentos se coloque diante deles como instância que julga e que decide, sem que esse julgar e esse decidir possam eles mesmos ser reconduzidos ao plano que está a ser julgado. O paciente que decide aceitar a sua doença incurável com uma determinada atitude, o prisioneiro que opta por preservar a sua dignidade interior perante condições que destroem tudo o que é exterior — esses actos procedem de algo que o condicionamento somático e psíquico pode dificultar, segundo Frankl, sem nunca conseguir suprimir inteiramente.

* * *

A ontologia dimensional, tal como Frankl a desenvolve ao longo de pelo menos seis obras distintas — com formulações que variam em extensão e mantêm a estrutura —, organiza-se em torno de duas leis que governam a relação entre dimensões. A primeira lei estabelece que quando uma mesma realidade é projectada de uma dimensão superior para uma dimensão inferior, as figuras resultantes contradizem-se entre si. A segunda lei estabelece que quando realidades diferentes são projectadas para uma mesma dimensão inferior, as figuras resultantes tornam-se indistinguíveis — o que Frankl designa como plurissignificância.

A analogia que Frankl emprega para ilustrar a primeira lei é a do copo. Na formulação mais rigorosa, que aparece em *Psicoterapia e Sentido da Vida* e é retomada em *On the Theory and Therapy of Mental Disorders* e em *Psicoterapia e Existencialismo*:

Se tomarmos uma e a mesma coisa numa dada dimensão e a projetamos em várias dimensões inferiores àquela que lhe é própria, a coisa em questão representa-se de tal modo que as

figuras obtidas se opõem umas às outras. Tomemos por exemplo, um copo, representado geometricamente sob a forma de cilindro, em um espaço tridimensional. Projetemo-lo em seguida nos planos horizontal e longitudinal, e teremos, num caso, um círculo, no outro, um retângulo. Observe-se, entretanto, que as figuras obtidas já se opõem enquanto se trata de um quadro fechado, ao passo que o copo é um recinto aberto.

(*Psicoterapia e Sentido da Vida*, p. 43)

O que a analogia demonstra excede a mera ilustração pedagógica. O que se discute aqui é um argumento sobre a natureza das oposições que a história da psicologia e da filosofia da mente produziu entre corpo e alma, entre o somático e o psíquico, entre o determinado e o livre. Se o ser humano é uma realidade tridimensional — somática, psíquica e noética — e se as teorias que o descrevem trabalham num plano bidimensional ou unidimensional, então as oposições que essas teorias encontram entre os seus dados podem ser artefactos da projecção, contradições aparentes que se dissolvem no momento em que a realidade é contemplada na dimensão que lhe é própria. O círculo e o rectângulo contradizem-se quando vistos no plano; o copo que os originou é uma unidade intacta no espaço tridimensional. A divergência entre Freud e Adler — o impulso sexual contra a vontade de poder — pode ser, nos termos desta analogia, uma divergência entre projecções bidimensionais de uma realidade que, na sua dimensão própria, é una.

Frankl não se limita à analogia do copo. Em *A Psicoterapia na Prática*, emprega a analogia da pirâmide para mostrar como a introdução de uma dimensão superior dissolve contradições que, nos planos inferiores, pareciam insolúveis. Um triângulo e um quadrado, vistos em planos bidimensionais distintos, opõem-se; e ambos são projecções de uma mesma pirâmide no

espaço tridimensional, e a pirâmide integra sem contradição aquilo que as suas projecções apresentam como incompatível. A consequência para a antropologia vai se tornando direta, porque quando uma teoria descreve o ser humano em termos de impulsos e outra em termos de intenções racionais, a oposição entre as duas pode indicar que ambas funcionam numa dimensão insuficiente para conter a unidade do fenómeno, sem que nenhuma delas tenha razão exclusiva sobre a outra. A dimensão noética, nos termos de Frankl, é a dimensão em que as oposições parciais se resolvem, porque é nela que o ser humano se apresenta na inteireza que as projecções parcelares inevitavelmente perdem.

A formulação contida em *El Hombre Doliente* acrescenta a segunda lei, que Frankl expõe com uma exactidão que as demais obras nem sempre igualam:

A segunda lei da ontologia dimensional é: Diversas coisas (não uma mesma), projetadas desde sua dimensão (não em diversas dimensões, mas sim) a uma mesma dimensão inferior, dão lugar a figuras (não contraditórias entre si, mas sim) que são polivalentes.

* * *

Esta segunda lei é mais consequente para a clínica do que a primeira, e o seu alcance merece ser percorrido com atenção. O que ela significa, traduzido para a linguagem psiquiátrica, é que quando fenómenos diferentes — um delírio esquizofrénico, uma crise mística genuína, uma alucinação histérica, uma visão com significado existencial — são todos projectados para o plano do psíquico, tornam-se indistinguíveis. A psiquiatria que trabalha exclusivamente no plano somático-psíquico não possui critérios para diferenciar aquilo que, na dimensão noética, são fenómenos radicalmente distintos. Qual seria a consequência terapêutica? Tratar indistintamente tudo o que se apresenta

como alucinação ou como discurso religioso ou como crise de sentido. No entanto, isto é perder a possibilidade de intervir com adequação, porque a intervenção adequada depende da dimensão em que o fenómeno tem a sua origem.

Frankl recorre ao exemplo de Dostoievski para tornar o ponto concreto: reduzido ao plano psiquiátrico, Dostoievski é um epilético; mantido na sua dimensão própria, é um epilético que é também um dos maiores escritores que a humanidade produziu, e a epilepsia, sendo real, não esgota o “fenómeno Dostoievski” nem o explica:

No mesmo instante em que eu, a partir do 'espaço' do humano — o espaço que só é constituído pela dimensão do espiritual —, projeto o elemento humano para o interior do 'plano' do meramente corpóreo e psíquico, qualquer fenómeno humano se mostra como plurissignificativo: a partir de então, em face de tal plurissignificância, não posso mais ver, por exemplo, nenhuma diferença entre a visão de um santo e a alucinação de uma histérica; e, por exemplo, no caso de Dostoievski, jamais posso saber se ele é apenas um epilético ou também é, contudo, alguma coisa mais.

(Logoterapia e Análise Existencial — Textos de Seis Décadas, p. 65-66)

A plurissignificância é, por isso, o nome técnico para o custo epistemológico da redução dimensional. Uma psiquiatria que trabalha em duas dimensões não erra naquilo que afirma — a epilepsia de Dostoievski é diagnosticável e tratável nos termos da neurologia — e permanece estruturalmente incapacitada de distinguir entre fenómenos que, no plano em que trabalha, se apresentam de modo idêntico. O santo e a histérica, o profeta e o delirante, o paciente que sofre por uma frustração pulsional e o paciente que sofre por uma perda de sentido — todos eles, projectados no plano do psíquico, geram figuras sobreponíveis. Só a reintrodução da dimensão que a projecção excluiu permite recuperar a distinção.

Esta observação tem consequências clínicas que Frankl explora em vários momentos da obra. O caso do paciente que apresenta aquilo que a nosologia convencional classifica como depressão, com sofrimento de origem existencial, exige uma intervenção que a farmacologia e a psicoterapia convencionais, por mais competentes que sejam nos seus domínios próprios, não podem fornecer — porque aquilo que ali se joga pertence a uma dimensão que escapa ao alcance dos seus instrumentos. Frankl é insistente neste ponto: o erro clínico vai além de falhar o diagnóstico — agrava a condição do paciente ao tratá-lo com instrumentos que pertencem à dimensão errada. Administrar um antidepressivo a um paciente cuja depressão tem origem numa neurose noogênica pode produzir alívio sintomático sem tocar na raiz do problema; administrar psicoterapia convencional a um paciente cujo sofrimento é genuinamente somático pode prolongar indefinidamente um tratamento que um diagnóstico correcto resolveria com rapidez. A adequação da intervenção ao plano de origem do sofrimento é o princípio clínico que a ontologia dimensional sustenta, e a sua violação — por ignorância, por hábito ou por ausência de categorias adequadas — é, na perspectiva de Frankl, responsável por uma porção considerável do fracasso terapêutico.

O caso narrado em *Psicoterapia e Sentido da Vida* ilustra o ponto de um outro ângulo. Uma paciente internada, a senhora Linek, sofria de uma condição que não cedia a nenhum dos tratamentos disponíveis. O sofrimento era real, prolongado e resistente. A intervenção de Frankl consistiu em tornar visível para a paciente que aquilo que ela fizera do seu sofrimento — a maneira como o enfrentara, a atitude com que o suportara — constituía, por si só, uma realização, e uma realização que as outras pacientes da clínica reconheciam como tal. O que esta intervenção mobilizou foi algo que pertence à dimensão noética, e não um mecanismo psíquico — sem reinterpretação cognitiva,

sem manejo transferencial, sem técnica de relaxamento: a capacidade de a paciente se posicionar perante o seu sofrimento e de reconhecer que o posicionamento, por si só, tem valor. A passagem da dimensão do sofrer para a dimensão do posicionar-se perante o sofrer é a passagem do psíquico para o noético, e é nessa passagem que a intervenção logoterapêutica age.

Um outro caso, relatado em *On the Theory and Therapy of Mental Disorders*, envolve uma paciente sem filhos que encontra, no diálogo com Frankl, a percepção de que o que importa no momento da morte é a existência de algo que se deixa no mundo, algo perante o qual a partida adquire gravidade porque havia algo pelo que partir significava perda — a necessidade de partir é universal e inescapável, e este outro elemento é o que pesa. A paciente sem filhos desespera por sentir que nada será afectado pela sua morte, e o que Frankl lhe mostra é que essa percepção, longe de ser um dado psicológico que precisa ser corrigido, é, na verdade, a expressão de uma exigência noética — a exigência de que a vida realizada deixe vestígio, e de que o vestígio confira ao conjunto da vida o seu carácter de plenitude ou de falta.

Estes casos clínicos tornam visível que a intervenção que funciona age numa dimensão que os outros quadros teóricos não reconhecem, e que a recusa de reconhecer essa dimensão conduz à impossibilidade de explicar por que razão a intervenção funciona. A eficácia clínica da logoterapia constitui, por esta via, o argumento empírico mais forte a favor da ontologia dimensional — mais forte do que a analogia do copo, mais forte do que a denúncia do reducionismo, mais forte do que qualquer argumento filosófico. O que a eficácia clínica demonstra é que há pacientes que melhoram quando se intervém na dimensão noética e que não melhoram com nenhuma outra forma de intervenção, e esta constatação, por si

só, exige uma explicação que os quadros bidimensionais não conseguem fornecer.

* * *

A força da analogia e a coerência interna das duas leis explicam a persistência da ontologia dimensional ao longo de toda a obra de Frankl — é um dos poucos instrumentos conceptuais que ele nunca abandona e nunca reformula substancialmente. A analogia do copo aparece em pelo menos cinco obras diferentes, sempre com a mesma estrutura e sempre com o mesmo propósito: demonstrar que a unidade do ser humano é compatível com a distinção das dimensões, e que a distinção das dimensões é necessária para que a unidade não seja confundida com a uniformidade. Que o ser humano é uno significa que não pode ser decomposto em partes; que se manifesta em três dimensões significa que a sua unidade é uma unidade complexa que exige, para ser compreendida, um aparato conceptual tridimensional.

É neste ponto que a ontologia dimensional encontra uma das suas formulações mais iluminadoras — e mais problemáticas. Em *El Hombre Doliente*, Frankl descreve a relação entre a pessoa e o organismo somático como uma relação instrumental:

A relação entre a pessoa e o organismo somático é uma relação instrumental; o espírito instrumentaliza o psicofísico; a pessoa maneja o organismo psicofísico, faz dele coisa «sua» fazendo dele ferramenta, *organon*, instrumento. A pessoa relaciona-se com o seu organismo como o músico com o «instrumento». Uma sonata não pode executar-se sem piano nem sem pianista. Mas esta comparação falha como toda comparação, já que o pianista é visível, enquanto o espírito é invisível (sem ser irreal por isso). A comparação falha porque o pianista e o piano estão num mesmo plano, literalmente

sobre o mesmo pódio, enquanto o espírito e o corpo não se encontram na mesma escala do ser.

A analogia do músico e do instrumento tem o mérito de captar algo que a analogia do copo não capta: a relação de uso. O copo demonstra a unidade multidimensional; o músico demonstra a operatividade — o facto de que a pessoa se serve do organismo psicofísico para realizar actos que pertencem à dimensão noética, do mesmo modo que o pianista se serve do piano para realizar a sonata. Frankl é honesto o suficiente para assinalar que a analogia falha num ponto decisivo: o pianista e o piano são realidades do mesmo plano, ambos visíveis, ambos materiais, ao passo que a pessoa e o organismo, na sua concepção, pertencem a planos distintos do ser. A invisibilidade do espírito — que não equivale a irreabilidade — e a diferença de plano ontológico entre quem usa e aquilo que é usado constituem a dificuldade que a ontologia dimensional precisa resolver e que a analogia, por melhor que seja, não resolve.

A distinção entre a *Person* e o *Charakter* — que Frankl formula em vários momentos e que receberá tratamento próprio no capítulo seguinte — está directamente ligada a esta estrutura. A *Person* é o quem, o sujeito irreduzível que decide; o *Charakter* é o como, o perfil empiricamente observável que resulta das decisões tomadas e das disposições herdadas. A *Person* pertence à dimensão noética; o *Charakter* manifesta-se na dimensão psíquica. Quando a psicologia estuda a personalidade — os traços, os padrões, as tendências estáveis —, estuda o *Charakter*; quando a logoterapia se dirige à instância que toma posição perante esses traços, perante esses padrões, e que é capaz de os confirmar ou de os contrariar, dirige-se à *Person*. A diferença entre as duas é a diferença entre a projecção bidimensional e a realidade tridimensional: o *Charakter* é aquilo que se vê quando a *Person* é projectada no plano do psicológico, e o que se perde nessa projecção é justamente o que faz da pessoa uma pessoa

— a liberdade, a responsabilidade, a capacidade de autodeterminação.

A reificação — o processo pelo qual a pessoa é tratada como coisa — é, nos termos da ontologia dimensional, o resultado directo desta projecção. Frankl cita Tomás de Aquino — *dominium sui actus*, o senhorio sobre os próprios actos — para designar o que se perde quando a pessoa é reduzida ao *Charakter*, quando o sujeito que quer é convertido num objecto que deve:

A pessoa humana, quando tratada meramente em termos de um mecanismo psíquico regido pela lei de causa e efeito, perde o seu carácter intrínseco como sujeito que é ultimamente autodeterminante. Deste modo, uma característica essencial da existência humana, a liberdade da vontade, foi totalmente descurada em qualquer interpretação exclusivamente psicodinâmica do ser humano. O sujeito que 'quer' foi convertido num objecto que 'deve'!

O que esta passagem articula é a consequência antropológica directa do reducionismo: quando se elimina a dimensão noética do quadro de compreensão, o ser humano deixa de ser sujeito e passa a ser objecto, por efeito da estrutura conceptual que, ao excluir a dimensão em que a subjectividade se constitui, torna a subjectividade invisível — sem que medeie qualquer decisão consciente de quem o estuda. A reificação, por isso, está longe de ser um acto de má vontade dos psicólogos e psiquiatras que trabalham em quadros bidimensionais — é uma consequência estrutural da insuficiência dimensional dos seus quadros, e só pode ser corrigida pela reintrodução da dimensão excluída.

* * *

O que a ontologia dimensional ataca directamente, e que constitui a razão pela qual Frankl a concebeu, é o reducionismo — aquilo que ele designa, numa expressão que retoma em quase

todos os seus livros, como o modo do *nada mais que*: o ser humano como *nada mais que* um organismo biológico, *nada mais que* um feixe de pulsões, *nada mais que* um produto das suas circunstâncias sociais, *nada mais que* um mecanismo de estímulo e resposta. O reducionismo, na visão de Frankl, consiste na projecção do humano para uma dimensão que lhe é inferior, com a consequente perda de tudo o que pertence à dimensão excluída. A redução é frequentemente apresentada como científica — como se a ciência consistisse em reduzir o complexo ao simples — quando, segundo Frankl, constitui uma amputação que se faz passar por explicação.

A crítica é extensa e aparece formulada em registos diferentes ao longo da obra. Em *On the Theory and Therapy of Mental Disorders*, Frankl distingue três formas de reducionismo: o biologismo, que explica o humano pelo orgânico; o psicologismo, que o explica pelo psíquico; e o sociologismo, que o explica pelo social. Em *Psicoterapia e Existencialismo*, a mesma crítica assume a forma de uma denúncia do *nothing-butness* — a tendência para desvalorizar os fenómenos humanos reduzindo-os às suas raízes mais simples, como se a raiz explicasse a planta inteira. Em *The Unheard Cry for Meaning*, a formulação é a mais incisiva que pude encontrar em toda sua obra:

O reducionismo é o niilismo de hoje. É verdade que o existencialismo de Jean-Paul Sartre gira em torno de «Ser e Nada», mas a lição a extrair do existencialismo é um nada hifenizado, a saber, o não-ser-coisa do ser humano. Um ser humano não é uma coisa entre outras coisas. As coisas determinam-se umas às outras. O homem, porém, determina-se a si mesmo. Antes, ele decide se se deixa ou não determinar, quer pelos impulsos e instintos que o empurram, quer pelas razões e significados que o puxam. O niilismo de ontem ensinava o nada. O reducionismo agora prega o nada-mais-que.

(*A Busca de Deus e Questionamentos sobre o Sentido*, p. 58)

A passagem condensa em poucas linhas a tese central: o reducionismo é a continuação do niilismo por outros meios. Onde o niilismo clássico negava o ser, o reducionismo contemporâneo nega o humano por uma via mais subtil — em vez de declarar que o homem não existe, declara que o homem é *nada mais que* aquilo que as ciências da matéria e da psique podem descrever. A redução é mais subtil do que a negação pura, porque preserva a aparência de respeito pelo fenómeno — o reducionista estuda o ser humano, produz dados sobre ele, publica artigos — ao mesmo tempo que elimina, pela estrutura do seu quadro conceptual, aquilo que tornaria o estudo completo.

O reducionismo tem razão dentro dos seus limites. Porém exclusivamente ali. O seu equívoco reside no pensamento unidimensional. Sobretudo frustra-se com ele o encontro de um sentido. O sentido de uma estrutura ultrapassa os seus componentes. Vale dizer que o sentido se situa em dimensão mais elevada do que os elementos que o constituem.

(*Psicoterapia para Todos*, p. 17)

A passagem, extraída de *Psicoterapia para Todos*, condensa o argumento central: o reducionismo funciona dentro dos limites da dimensão em que age, e torna-se falso no momento em que pretende que essa dimensão esgota a realidade. A consequência para a questão do sentido é directa: se o sentido pertence a uma dimensão mais elevada do que os elementos que constituem o fenómeno, então nenhuma análise que se confine aos elementos pode encontrá-lo. A psicanálise pode analisar exaustivamente os mecanismos pulsionais de um paciente sem jamais tocar na questão de saber se aquela vida tem sentido, e pode fazê-lo por constituição — a dimensão em que o sentido se situa está, por definição, fora do seu alcance.

O alcance da crítica de Frankl vai além da psiquiatria. Quando descreve o reducionismo como niilismo, Frankl está a

identificar um traço civilizacional que excede largamente os limites da prática clínica. A percepção de que houve, ao longo do século XX, uma perda massiva da compreensão do que o ser humano é — uma perda que se manifesta na tendência para explicar o comportamento humano como se fosse inteiramente determinado por mecanismos biológicos, por condicionamentos sociais ou por dinâmicas inconscientes, sem que reste nada que essas explicações não cubram — é uma percepção que a prática clínica confirma quotidianamente, e que Frankl articula com uma insistência que percorre toda a obra. O paciente que chega ao consultório convicto de que os seus impulsos o determinam, de que as suas circunstâncias o definem, de que a sua bioquímica o governa, é um paciente que interiorizou o reducionismo como visão de si mesmo, e essa interiorização é parte do problema — porque ao aceitar que é *nada mais que* aquilo que o condiciona, o paciente renuncia à possibilidade de se posicionar perante o condicionamento, e é essa renúncia que torna o condicionamento absoluto.

Frankl tem consciência de que a denúncia do reducionismo comporta um risco simétrico que ele designa como noologismo — a redução, desta vez inversa, de todos os fenómenos à dimensão espiritual, como se o somático e o psíquico fossem negligenciáveis. O noologismo seria, por exemplo, interpretar uma depressão endógena como culpa existencial e recusar a intervenção farmacológica em nome de uma concepção puramente espiritual do sofrimento. Frankl menciona o risco com frequência suficiente para que se perceba que o considera real, e a sua insistência na tridimensionalidade — recusando qualquer hierarquia que subalternizasse as duas dimensões inferiores — é em parte uma resposta a essa possibilidade. O que a ontologia dimensional propõe é que as três dimensões funcionam em simultâneo, que nenhuma delas pode ser suprimida sem perda de compreensão, e que a intervenção

terapêutica adequada depende de um diagnóstico que localize a origem do sofrimento na dimensão correcta. A um sofrimento de origem somática corresponde uma intervenção somática; a um sofrimento de origem psíquica corresponde uma intervenção psicoterápica; a um sofrimento de origem noética — a neurose noogênica — corresponde uma intervenção logoterapêutica. O erro, em qualquer direcção, consiste em intervir numa dimensão alheia à origem do problema.

A distinção entre agressão e ódio, que Frankl articula em *A Psicoterapia na Prática*, oferece um exemplo revelador de como a plurissignificância se manifesta na análise psicológica concreta. A agressão, tal como a psicanálise freudiana a concebe e como a etologia de Lorenz a descreve, é uma descarga pulsional — uma quantidade de energia acumulada que procura uma saída e que se dirige a objectos que servem como alvos dessa descarga. O sujeito agressivo, neste quadro, é uma espécie de vítima indefesa do seu próprio impulso: a agressividade pressiona e ele limita-se a encontrar objectos nos quais descarregá-la. O que esta descrição omite — e que constitui, para Frankl, a sua limitação decisiva — é o aspecto da intencionalidade. Na dimensão dos fenómenos propriamente humanos, o que existe é o ódio, e o ódio distingue-se da agressão porque é dirigido intencionalmente para algo que o sujeito odeia. A agressão é cega; o ódio tem objecto. A diferença entre os dois é exactamente a diferença que a segunda lei da ontologia dimensional descreve: projectados para o plano do biológico, a agressão animal e o ódio humano são indistinguíveis — ambos se apresentam como activação fisiológica dirigida a um alvo — e na dimensão noética são fenómenos radicalmente distintos, porque o ódio pressupõe um sujeito que avalia, que julga, que atribui ao objecto uma qualidade que justifica a hostilidade, e essa avaliação excede o que a descarga pulsional, enquanto mecanismo biológico, pode produzir.

A consequência acaba por ser bastante grave (quase iatrogênia): tratar o ódio como se fosse agressão — intervir sobre os mecanismos de descarga pulsional quando o que ali se joga é uma avaliação existencial. Isto equivale a tratar o efeito e ignorar a causa, com o resultado previsível de que o tratamento não funciona ou produz alívio sintomático sem tocar na raiz. O paciente cujo ódio procede de uma injustiça real que experimentou e perante a qual se posiciona com a totalidade do seu ser dispensa o manejo pulsional, e exige que a injustiça seja reconhecida como tal e que a sua relação com ela seja examinada nos termos que lhe são próprios — os termos noéticos da atitude, da avaliação e da decisão. A psiquiatria que trabalha sem a dimensão noética não possui sequer a linguagem para formular esta distinção, e a plurissignificância encarrega-se de tornar invisível aquilo que, uma vez visto, se revela como a diferença entre dois fenómenos que apenas no plano bidimensional se confundem.

Há um outro aspecto da plurissignificância que Frankl examinou com atenção particular e que diz respeito à relação entre o estado afectivo do paciente e a sua capacidade de emitir juízos sobre o valor da própria existência. Em *A Psicoterapia na Prática*, Frankl observa que o paciente cuja vida emocional está perturbada — por depressão, por angústia, por uma disposição sombria que colora a totalidade da experiência — tende a formular juízos sobre o sentido ou a falta de sentido da sua vida que são, na realidade, ditados pela disposição afectiva e que, por essa razão, não possuem valor cognitivo. O paciente deprimido que declara que a sua vida é desprovida de sentido está, em muitos casos, a traduzir para a linguagem do juízo existencial aquilo que é, na sua origem, um estado de humor — e essa tradução torna-se possível porque, no plano bidimensional em que o paciente se move sem o saber, o estado afectivo e o juízo existencial são plurissignificantes: apresentam-se de modo

idêntico, embora pertençam a dimensões distintas. O que Frankl recomenda nestes casos é que o paciente seja exortado a não confundir os seus juízos de valor com verdades sobre a sua existência — a reconhecer que o pensamento catatímico, o pensamento arrastado pela corrente afectiva, é incapaz de atingir a realidade do sentido e que, quanto mais afectada pela doença se encontra a sua vida sentimental, mais deve suspender esses juízos e apoiar-se em dados que procedem de outra ordem.

A relevância desta observação para o problema da plurissignificância é que ela demonstra, no plano concreto da clínica, como fenómenos de dimensões diferentes se confundem quando projectados para um mesmo plano. O estado depressivo (dimensão somático-psíquica) e a perda genuína de sentido (dimensão noética) produzem, ao nível do relato do paciente, enunciados idênticos: «a minha vida não tem sentido», «tudo é vazio», «nada vale a pena». A psiquiatria bidimensional trata ambos os casos com os mesmos instrumentos — farmacologia e psicoterapia convencional — porque não dispõe de critérios para os distinguir. A ontologia dimensional vai permitir a distinção: se a origem é somática (depressão endógena), a intervenção farmacológica torna-se necessária e a intervenção logoterapêutica é, no melhor dos casos, complementar; se a origem é noética (frustração existencial genuína), a intervenção farmacológica pode mascarar o problema sem o resolver, e a intervenção adequada pertence a uma ordem diferente. A capacidade de fazer esta distinção é, nos termos de Frankl, o que a ontologia dimensional oferece à clínica que nenhum outro quadro teórico consegue oferecer — e o preço de não a fazer é, em muitos casos, a perpetuação de um sofrimento que tinha solução.

* * *

A inteligência clínica desta posição manifesta-se também no domínio da medicina psicossomática, onde Frankl inverte a pergunta habitual. A medicina psicossomática tradicional pergunta por que razão alguém adoece — por que é que um conflito psicológico se converte num sintoma orgânico. Frankl, em *On the Theory and Therapy of Mental Disorders*, sugere que a pergunta mais fecunda é a inversa: por que razão alguém permanece saudável apesar dos conflitos, das tensões, dos condicionamentos que deveriam, segundo os modelos vigentes, produzir doença? A resposta, nos seus termos, remete para a dimensão noética: o que mantém saudável é a presença de sentido, a orientação para algo que excede o conflito e que torna o conflito suportável, a capacidade de se posicionar perante aquilo que condiciona em vez de ser determinado por isso. A passagem da medicina psicossomática para o que Frankl chama de saúde psicossomática — da patogénese para a salutogénese — é uma das consequências mais fecundas da ontologia dimensional, e uma que a medicina contemporânea, sob outras denominações, tem vindo a confirmar.

* * *

A ontologia dimensional possui ainda uma consequência que excede o domínio diagnóstico e que toca a própria estrutura motivacional do ser humano. Frankl observa que a procura directa do prazer é um princípio auto-derrotante — quanto mais alguém se propõe deliberadamente alcançar o prazer, menos o obtém, porque o prazer é um efeito lateral do cumprimento de uma intenção dirigida a outra coisa, e destrói-se na medida em que é convertido em objectivo. A observação é clinicamente verificável e constitui, segundo Frankl, o mecanismo etiológico subjacente à maioria dos casos de neurose sexual: o paciente que se concentra no prazer durante o acto sexual perde-o por essa concentração, porque a atenção dirigida ao efeito interrompe o

processo que o produziria. O mesmo mecanismo age, por analogia, em todas as situações em que o ser humano tenta alcançar por via directa aquilo que só se obtém como consequência lateral de uma orientação para algo que o excede.

A imagem que Frankl emprega para condensar esta observação é a do bumerangue australiano: o bumerangue só regressa ao caçador quando erra o alvo. Do mesmo modo, o ser humano só regressa a si mesmo — só se torna preocupação para si mesmo — quando errou a sua missão, quando falhou em encontrar um sentido para o qual se dirigir. A autopreocupação, a autoobservação, a fixação no próprio estado interior são, nos termos de Frankl, sintomas de uma vontade de sentido frustrada, e a tentativa de os tratar como problemas em si mesmos — através de técnicas de auto-conhecimento, de exploração do mundo interior, de reforço da auto-estima — agrava a condição em vez de a resolver, porque mantém o paciente orientado para si quando aquilo de que necessita é ser orientado para fora de si. A terapia que funciona é a que redirige a atenção do paciente para o sentido, e a que o redirige com sucesso age, por necessidade, na dimensão noética — porque é na dimensão noética que a orientação para o sentido se constitui.

A tríade do fracasso que a logoterapia identifica nos pacientes mais gravemente afectados — a incapacidade de trabalhar, a incapacidade de sentir prazer e a incapacidade de sofrer com sentido — corresponde, nos termos da ontologia dimensional, a três formas de bloqueio da dimensão noética. A incapacidade de trabalhar procede de uma ausência de razão para trabalhar — de uma perda da percepção de que o trabalho realiza algo que excede o próprio trabalhador — mais do que de uma deficiência de competência ou de motivação no sentido psicológico. A incapacidade de sentir prazer — que se apresenta clinicamente como uma espécie de depressão vegetativa — procede, nos casos noogénicos, da tentativa frustrada de obter

por via directa aquilo que só vem como efeito lateral. E a incapacidade de sofrer com sentido — que pode conduzir à ideação suicida e exigir hospitalização — procede da percepção de que o sofrimento é absolutamente gratuito, de que nada se realiza ao suportá-lo, de que a resistência perante o sofrimento é tão vazia quanto o sofrimento em si. Em cada um destes três casos, o que está bloqueado é uma faculdade noética — a orientação para o sentido no trabalho, no prazer e no sofrimento — e o que a desbloqueia é uma intervenção que toca essa dimensão.

É nesta convergência entre a análise motivacional e a análise dimensional que a ontologia de Frankl revela a sua coerência interna mais profunda. A tridimensionalidade soma-psique-noético funciona como mais do que um esquema classificatório que organiza fenómenos em categorias — embora também o faça. É um instrumento que permite explicar por que razão certas intervenções funcionam e outras fracassam, por que razão certos pacientes melhoram e outros estagnam, por que razão certas formas de sofrimento resistem a tudo o que a psiquiatria bidimensional pode oferecer. O que a ontologia dimensional explica, no fundo, é que há uma dimensão da existência humana que a psiquiatria moderna excluiu do seu quadro conceptual por razões metodológicas — a dimensão onde se colocam as questões do sentido, do valor, da atitude perante o destino, da relação com a totalidade da vida — e que essa exclusão, longe de ser neutra, produz efeitos clínicos verificáveis sob a forma de diagnósticos inadequados, intervenções ineficazes e pacientes que, tratados nas dimensões erradas, continuam a sofrer.

* * *

A robustez da ontologia dimensional como instrumento descritivo e como princípio de organização clínica é considerável. Que o ser humano não se esgota naquilo que a

biologia pode dizer sobre ele é uma constatação que poucos contestariam; que há formas de sofrimento cuja origem nem é orgânica nem psicogénica é uma observação clínica que qualquer psiquiatra atento pode confirmar; que a tentativa de reduzir todo o sofrimento humano a categorias biológicas ou psicológicas empobrece o diagnóstico e a intervenção é uma consequência que se segue das duas anteriores com um grau elevado de plausibilidade. Nada disto é negligenciável, e o facto de estas constatações terem sido feitas por Frankl num momento em que a psiquiatria predominante estava fortemente comprometida com modelos reducionistas confere à sua contribuição um valor histórico que permanece intacto.

O que a ontologia dimensional não consegue, porém, é demonstrar que o noético constitui uma dimensão ontológica no sentido forte do termo — que existe efectivamente uma camada do ser humano que possui estatuto ontológico próprio e que não pode ser explicada, sequer em princípio, como uma função de ordem superior do psíquico. A analogia do copo é esclarecedora enquanto analogia, e uma analogia geométrica não constitui uma prova ontológica. Que o copo, no espaço tridimensional, é uma unidade que se fragmenta quando projectada em planos bidimensionais é verdade por definição — o copo é tridimensional. O que está por demonstrar é que o ser humano é tridimensional no sentido que Frankl propõe, e não bidimensional com uma vida psíquica suficientemente complexa para gerar os fenómenos que Frankl atribui ao noético. A distinção é decisiva: se o noético for uma dimensão ontológica genuína, então o sistema de Frankl está assente num dado de natureza; se for uma função de ordem superior do psíquico, então o sistema continua a funcionar com eficácia descritiva — os fenómenos que Frankl identifica são reais e clinicamente verificáveis — e a fundação ontológica que ele reivindica não

existe, e tudo o que se constrói sobre essa reivindicação precisa de ser repensado.

Frankl não enfrenta esta questão com a profundidade que ela exige. A sua posição é, em geral, fenomenológica — o noético apresenta-se na experiência como irreduzível, e a tentativa de o reduzir ao psíquico destrói o fenómeno — e a fenomenologia pode descrever a irreduzibilidade sem a fundamentar ontologicamente. Que algo se apresente como irreduzível na experiência é compatível com a possibilidade de que, numa ordem de explicação mais abrangente, essa irreduzibilidade se dissolva. A percepção de uma cor apresenta-se como irreduzível na experiência — o vermelho não parece ser uma frequência de onda electromagnética — e a ciência demonstra que é exactamente isso. A mesma possibilidade, pelo menos em princípio, aplica-se ao noético: aquilo que na experiência clínica se apresenta como uma dimensão distinta pode, numa ordem de explicação mais completa, revelar-se como uma modalidade complexa do psíquico. Frankl precisava de um argumento que excluísse esta possibilidade, e esse argumento não se encontra na sua obra.

O argumento existe, porém, e a tradição filosófica que o articula é longa e rigorosa. A questão que Frankl deveria ter formulado — e que, por razões que teremos ocasião de examinar, nunca formulou com a exactidão necessária — é a seguinte: há, no ser humano, faculdades cujas características são tais que nenhum princípio material, por mais complexamente organizado que esteja, poderia produzi-las? Se a resposta for afirmativa, então essas faculdades procedem necessariamente de um princípio que excede o material, e a dimensão noética está ontologicamente fundada. Se a resposta for negativa, então tudo o que Frankl atribui ao noético é, em princípio, reconduzível ao psíquico, e a fundação ontológica desaparece.

A tradição aristotélico-tomista responde afirmativamente, e fá-lo com um argumento independente de observações fenomenológicas e de analogias geométricas. O argumento parte da natureza de certas operações — as operações intelectuais — e mostra que essas operações possuem características incompatíveis com qualquer princípio material. A capacidade de apreender o universal — de compreender que o conceito de triângulo se aplica a todos os triângulos possíveis e não somente ao triângulo que se tem diante dos olhos — produz um resultado que excede, por definição, a capacidade de qualquer órgão particular. O olho vê este triângulo; a imaginação retém a imagem deste triângulo e pode reproduzi-la na sua ausência; e o intelecto apreende o triângulo na sua essência — o que é ser triângulo —, e essa apreensão é uma captação do que há de comum a todos os casos possíveis, incluindo os que nunca foram e nunca serão observados, e não uma generalização a partir de casos particulares (uma generalização permanece no plano do particular, somando casos). Nenhuma operação que dependa de um órgão material — e todo o psíquico, por definição, depende de um órgão material, o sistema nervoso — é capaz de produzir este resultado, porque o órgão material é necessariamente particular, e o particular não contém o universal.

O mesmo se aplica ao juízo — à operação pela qual o intelecto afirma ou nega algo sobre algo e sabe que o que afirma é verdadeiro ou falso. O juízo «a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos rectos» descreve uma necessidade que se aplica a todos os triângulos, e essa necessidade é conhecida como tal pelo intelecto que a formula — sem que descreva qualquer observação particular. A certeza que acompanha este tipo de juízo é de uma natureza radicalmente diferente da certeza que acompanha, por exemplo, a sensação de dor quando se toca numa superfície quente: a

primeira é uma certeza sobre o que as coisas são em si mesmas, a segunda é uma certeza sobre como as coisas me afectam. Nenhuma operação que dependa inteiramente de um princípio material é capaz de atingir a primeira — porque o princípio material está necessariamente imerso nas suas condições particulares e não pode, a partir delas, alcançar o que é necessário e universal.

E aplica-se ainda à vontade — à operação pela qual o ser humano quer um bem enquanto bem, e não somente enquanto satisfação de um apetite particular. O apetite responde ao bem particular: a fome quer este alimento, o desejo sexual quer este parceiro, a ira quer a remoção deste obstáculo. A vontade, na acepção rigorosa do termo, orienta-se para o bem enquanto bem — para aquilo que é bom independentemente de satisfazer este ou aquele apetite particular —, e é essa orientação que torna possível a deliberação, a escolha entre bens incompatíveis, e a decisão de renunciar a um bem particular em nome de um bem superior. A vontade assim entendida coincide com aquilo que Frankl chama de dimensão noética quando a descreve como a instância que se posiciona perante os condicionamentos, que decide se se deixa ou não determinar, que escolhe uma atitude. O que Frankl descreve fenomenologicamente — e com acerto — como liberdade de atitude é, na linguagem das faculdades, a operação da vontade enquanto apetite intelectual, e essa operação, pelas mesmas razões que tornam o intelecto irreduzível ao sensitivo, é igualmente irreduzível a qualquer princípio material.

Se Frankl tivesse disposto destes instrumentos, a sua ontologia dimensional teria uma fundação que a analogia do copo, por mais esclarecedora que seja, nunca poderia fornecer. A distinção entre o noético e o psíquico deixaria de depender de uma descrição fenomenológica — que o adversário pode aceitar como descrição sem aceitar como prova — e passaria a apoiar-

se numa demonstração da irredutibilidade de certas operações a qualquer princípio material. A pessoa que julga, a pessoa que quer o bem enquanto bem, a pessoa que apreende o universal — essa pessoa age com um princípio que excede, por natureza, aquilo que o corpo e a psique, enquanto realidades materialmente dependentes, podem produzir. E é esse excesso que constitui a dimensão noética, na qualidade de dado ontológico mais do que de postulado fenomenológico.

É significativo que o corpus de trabalho clínico e formativo que articula a logoterapia de Frankl com a tradição das faculdades da alma tenha chegado, por via independente, a constatações que confirmam a solidez da intuição frankliana e ao mesmo tempo revelam aquilo que lhe falta. A actividade psíquica, compreendida na sua articulação interna, manifesta-se como exercício do senso comum, da razão, do apetite concupiscível, da vontade, do apetite irascível, do intelecto activo e do intelecto passivo — sete faculdades cuja distinção permite descrever, com um grau de exactidão que a ontologia dimensional não alcança, a diferença entre o que no ser humano é partilhado com os outros animais e o que é exclusivamente seu. A vontade, compreendida como faculdade que se dirige às outras faculdades e que se expande na medida em que essas faculdades amadurecem — sendo que esse amadurecimento passa pela progressão do senso comum para a razão, do apetite concupiscível para o irascível, e destes para os intelectos —, e não como simples impulso, é uma realidade que a prática clínica verifica constantemente, e que corresponde, nos termos de Frankl, ao que ele chama de dimensão noética, sem que Frankl tenha tido acesso à estrutura interna que dá a essa dimensão a sua inteligibilidade. O amadurecimento é, neste quadro, a abertura progressiva das possibilidades de apreender o mundo com faculdades superiores — de captar mais significado, mais ordem, mais verdade — e é essa abertura que constitui, no plano

clínico, a diferença entre um paciente preso ao plano dos apetites particulares e um paciente capaz de se orientar pelo bem universal. A ontologia dimensional de Frankl capta algo de real. O que lhe falta é a gramática interna que permite dizer com exactidão o que é esse algo.

* * *

A questão da fundação não é uma questão meramente académica, e a sua urgência torna-se visível quando se considera a dimensão civilizacional do problema que a ontologia dimensional pretende resolver. A constatação de que existe um número crescente de pessoas em busca infrutífera de sentido — empiricamente documentada, como Frankl recorda, por investigações como a de Yalom, segundo a qual trinta por cento dos pacientes que se apresentavam numa clínica ambulatorial de psiquiatria tinham como problema central a questão do sentido — indica que o fenómeno que a ontologia dimensional descreve é uma condição difusa que afecta proporções significativas da população e que os quadros teóricos vigentes não conseguem abordar adequadamente, longe de ser uma curiosidade teórica ou uma particularidade de certos pacientes atípicos. A despersonalização e a desumanização que Frankl denuncia em *The Unheard Cry for Meaning* são, nos seus termos, consequências directas de uma antropologia truncada que se infiltrou para além da psiquiatria, alcançando a cultura como um todo:

Não é possível lidar com os males e enfermidades de uma época como a nossa, uma de falta de sentido, despersonalização e desumanização, a menos que a dimensão humana, a dimensão dos fenómenos humanos, seja incluída no conceito de homem que subjaz indispensavelmente a toda forma de psicoterapia. (...) Resumindo, pode-se dizer que a psicanálise nos ensinou a desmascarar o neurótico, e o behaviorismo nos ensinou a desmitificar a neurose. Agora a

logoterapia está nos ensinando a «reumanizar» tanto a psicanálise como o behaviorismo.

A reumanização que Frankl propõe é, nos seus termos, a reintrodução da dimensão noética nos quadros de compreensão que a haviam excluído. O que torna esta proposta mais do que um gesto retórico é o facto de que a exclusão da dimensão noética tem consequências verificáveis: pacientes que não são tratados na dimensão adequada não melhoram; populações inteiras que interiorizaram uma visão reducionista de si mesmas experimentam um vazio que nenhuma prosperidade material suprime; sistemas terapêuticos que trabalham exclusivamente no plano bidimensional encontram, com frequência crescente, pacientes cujo sofrimento não responde aos seus instrumentos. A ontologia dimensional é a resposta de Frankl a esta situação, e a sua fecundidade clínica ao longo de décadas confirma que a resposta capta algo de real. A fecundidade clínica, por si só, não demonstra a verdade ontológica da tese, e é nesse intervalo — entre a fecundidade clínica e a demonstração ontológica — que o sistema permanece vulnerável.

O homem despretenso e simples, como Frankl observa, sabe de modo pré-reflexivo que a vida tem sentido e que esse sentido pode ser realizado mesmo nas condições mais adversas — pela criação, pela vivência, pela atitude perante o sofrimento inevitável. Esse saber pré-reflexivo é, nos termos de Frankl, uma autocompreensão ontológica da qual se poderia destilar uma axiologia inteira. A formulação é notável: Frankl reconhece que o fundamento do sentido existe na experiência comum e que a teoria deveria destilar — tornar explícito e articulado — aquilo que a experiência contém de modo implícito. O que Frankl reconhece sem o formular de modo completo é que essa destilação exige instrumentos que a fenomenologia, por si só, não possui — porque a fenomenologia descreve a experiência tal como se apresenta, sem demonstrar por que razão a

experiência se apresenta assim e não de outro modo. A demonstração pertence à metafísica, e é a metafísica que a ontologia dimensional solicita sem a incorporar.

A analogia do logoterapeuta como oculista — que Frankl propõe em *En el principio era el sentido* — é reveladora desta tensão. O logoterapeuta, diz Frankl, distingue-se do pintor: o pintor pinta a realidade tal como ele a vê; o oculista ajuda o paciente a ver a realidade tal como ela é. O logoterapeuta amplia o campo de visão do paciente para que este possa perceber sentidos e valores que antes lhe escapavam. A analogia pressupõe que o sentido está lá — na realidade, independentemente do paciente — e que o trabalho terapêutico consiste em remover os obstáculos à sua percepção. E se o sentido está lá como dado objectivo, então a pergunta ontológica regressa com toda a força: em que consiste esse «estar lá»? Que tipo de realidade é o sentido para que possa estar na situação antes de ser percebido pelo sujeito? A fenomenologia pode descrever a experiência de descoberta — o paciente que, num momento, não via o sentido e, no momento seguinte, o vê —, sem poder fundamentar a afirmação de que o sentido existia antes de ser visto. Essa fundamentação exige uma teoria da realidade do valor que Frankl não fornece, e cuja ausência constitui uma das lacunas que este livro se propõe examinar.

* * *

O que se encontra na obra de Frankl, em lugar do argumento ontológico que o sistema pediria, é uma descrição tão coerente e tão consistente ao longo de seis décadas de trabalho clínico que adquiriu, pela sua própria persistência, um peso próximo do demonstrativo sem o ser formalmente. A experiência clínica acumulada de Frankl, corroborada por gerações de logoterapeutas que identificam nas suas práticas os mesmos fenómenos que ele descreveu, constitui o que se

poderia chamar de evidência convergente — múltiplas observações independentes que apontam na mesma direção sem que nenhuma delas, individualmente, constitua prova. A pergunta que fica em aberto — e que este livro procurará responder na medida do possível — é se essa evidência convergente pode ser traduzida numa fundação filosófica que sustente aquilo que a clínica sugere e que a fenomenologia descreve.

O peso da evidência convergente merece ser apreciado na sua justa medida, porque é sobre ele que a prática logoterapêutica se sustenta na ausência da fundação filosófica que lhe falta. A convergência manifesta-se em vários planos. No plano clínico, os fenômenos que Frankl descreve — a neurose noogênica, o vazio existencial, a frustração da vontade de sentido, a eficácia da intenção paradoxal e da derreflexão — foram identificados e confirmados por terapeutas que trabalham em contextos culturais diversos, com populações diferentes e em épocas distintas. No plano epidemiológico, a proporção de pacientes cujo sofrimento tem componente existencial tem sido documentada com instrumentos quantitativos — os testes logoterapêuticos desenvolvidos ao longo de décadas, as investigações independentes como a de Yalom, os estudos que confirmam a correlação entre falta de sentido e vulnerabilidade psicopatológica. No plano fenomenológico, a descrição de Frankl coincide com o que qualquer observador atento reconhece na experiência comum: que há no ser humano algo que se posiciona, que julga, que decide, que sofre por razões alheias ao que o corpo e a psique, tomados isoladamente, podem explicar.

Nenhuma destas convergências é uma demonstração. Cada uma delas é compatível, pelo menos em princípio, com a hipótese de que o noético é uma função complexa do psíquico e não uma dimensão autónoma. A convergência torna a

hipótese reducionista cada vez menos plausível — porque seria necessário explicar por que razão uma função complexa do psíquico se comporta, em todos os contextos observados, como se fosse uma dimensão distinta — e não a exclui formalmente. E enquanto a exclusão formal não for produzida, o sistema permanece no estatuto de intuição clínica massivamente confirmada e filosoficamente não demonstrada, uma posição forte para a prática e frágil para a teoria. O terapeuta que trabalha com a ontologia dimensional e que verifica, na sua clínica, a eficácia das intervenções noéticas tem razão prática para manter a sua posição; o filósofo que pergunta se essa eficácia demonstra a existência ontológica de uma terceira dimensão tem razão teórica para a questionar. O trabalho que fica por fazer é o que permitiria satisfazer ambos — produzir a demonstração que daria à razão prática o suporte teórico que ela merece e que, enquanto não o recebe, a deixa exposta.

A analogia do copo, com as duas leis que a sustentam, constitui o ponto de entrada para toda a logoterapia. Nenhum dos conceitos que serão examinados ao longo deste livro — a autotranscendência, o autodistanciamento, a vontade de sentido, a consciência como órgão do sentido, a neurose noogênica, o supra-sentido — pode ser compreendido sem que se tenha primeiro compreendido o que está implicado na afirmação de que o ser humano se manifesta em três dimensões ontologicamente distintas. Cada um desses conceitos pressupõe a dimensão noética como condição de possibilidade: a autotranscendência é um acto noético, o autodistanciamento é um acto noético, a vontade de sentido é uma motivação noética, a consciência é um órgão noético, a neurose noogênica é uma patologia de origem noética, o supra-sentido é uma questão que só se coloca na dimensão noética. Se a dimensão noética não existir como dimensão própria — se for, como os seus críticos sustentam, uma função complexa do psíquico que Frankl ergueu

indevidamente ao estatuto de dimensão autónoma —, então todo o edifício conceitual perde a sua base e precisa de ser reconstruído sobre outros fundamentos. Se existir, como Frankl sustenta e como a experiência clínica acumulada sugere, então a tarefa que se impõe é dar-lhe a fundação que Frankl não lhe deu, e é essa tarefa que organiza os capítulos que se seguem.

A questão com que ficamos é, por isso, uma questão de fundação, e os seus termos podem agora ser formulados com a exactidão que o desenvolvimento anterior permite. A ontologia dimensional descreve, com consistência e fecundidade clínica verificadas ao longo de seis décadas, uma estrutura tridimensional do ser humano que inclui uma dimensão — a noética — irredutível às outras duas. A fenomenologia confirma a descrição: quem examina o fenómeno sem pressupostos reducionistas reconhece na experiência humana actos que não se deixam explicar por mecanismos somáticos nem por dinâmicas psíquicas. A clínica corrobora: pacientes cujo sofrimento tem origem noética melhoram com intervenções noéticas e não melhoram com nenhuma outra. A fenomenologia e a clínica, tomadas isoladamente, não constituem fundação ontológica. A fenomenologia descreve a irredutibilidade sem a demonstrar, e a clínica verifica a eficácia sem explicar por que razão a eficácia se verifica. O que falta é um argumento de natureza metafísica — um argumento que mostre, a partir da natureza das operações em jogo, que essas operações procedem necessariamente de um princípio que excede o material, e que esse princípio é o que a ontologia dimensional designa como noético.

A tradição filosófica que dispõe deste argumento identifica, como vimos, três operações cuja natureza é incompatível com qualquer princípio material: a apreensão do universal, o juízo e a vontade orientada para o bem enquanto bem. Que Frankl não tenha recorrido a esta tradição — que tenha permanecido no

plano fenomenológico ao longo de toda a obra — não diminui a acuidade com que identificou o fenómeno, e explica por que razão o fenómeno permanece, no seu sistema, no estatuto de intuição confirmada pela clínica e não no estatuto de tese demonstrada pela filosofia. A passagem de um estatuto ao outro é o que a ontologia dimensional solicita e o que a obra de Frankl, pelos seus recursos, não pôde realizar.

A questão da fundação ontológica é a mais grave que a ontologia dimensional deixa em aberto, e tem ao seu lado uma segunda questão, de alcance igualmente considerável, que toca a diferença entre a *Person* e o *Charakter* — entre o sujeito irreduzível que decide e o perfil empírico que as decisões, as disposições e as circunstâncias produzem. Frankl reconhece a diferença, formula-a em vários momentos da obra e atribui-lhe uma importância que o leitor atento percebe sem dificuldade. A diferença, uma vez formulada, exige uma articulação que Frankl não fornece: em que consiste, exactamente, a *Person*? Que relação mantém com o *Charakter*? É possível descrever a *Person* sem recair no vocabulário do *Charakter*, dado que tudo o que se pode observar, medir e descrever pertence, por definição, ao plano do empírico? A *Person* é acessível à reflexão ou é, como Frankl por vezes sugere, um dado último irreduzível que só se manifesta no acto de decidir? E se é um dado último, como se distingue de uma hipótese vazia — de um nome atribuído àquilo que resta quando tudo o que é descritível foi subtraído?

Estas perguntas não são periféricas. A distinção entre *Person* e *Charakter* é, dentro do sistema de Frankl, o desdobramento imediato da ontologia dimensional — é o ponto em que a tridimensionalidade, concebida como estrutura geral do humano, se concretiza na descrição de como, no indivíduo singular, a dimensão noética se relaciona com as dimensões somática e psíquica. Se a ontologia dimensional é a moldura, a distinção *Person/Charakter* é a articulação interna da moldura,

aquilo que permite passar da afirmação genérica de que «o ser humano tem três dimensões» para a descrição concreta de como essas três dimensões se articulam numa pessoa particular. Que Frankl tenha formulado a distinção sem a articular com o rigor que ela exige é, de novo, uma consequência da ausência de instrumentos metafísicos na sua formação — e é, de novo, uma lacuna que solicita o trabalho de fundação que a obra por si só não pôde realizar.

A relação instrumental entre a pessoa e o organismo — a pessoa que se serve do organismo psicofísico como o músico se serve do instrumento, segundo a formulação de *El Hombre Doliente* — é o ponto mais avançado a que Frankl chega nesta direcção. A analogia, como o próprio Frankl reconhece, falha num ponto decisivo: o músico e o instrumento pertencem ao mesmo plano do ser, ao passo que a pessoa e o organismo, na sua concepção, pertencem a planos distintos, e a natureza dessa distinção de planos é o que está por esclarecer. Que a pessoa «manuseie» o organismo psicofísico indica uma relação de uso, de instrumentalização, de subordinação operativa — e dizer isto é descrever a relação sem a fundamentar, e a pergunta sobre o que torna essa relação possível permanece sem resposta. A resposta exigiria uma teoria da pessoa — uma metafísica do sujeito enquanto sujeito — que Frankl esboça em traços fenomenológicos sem nunca a desenvolver com a exactidão que o conceito pede. É esse desenvolvimento que o capítulo seguinte procurará iniciar.

* * *

O que distingue a posição deste livro da recepção habitual da ontologia dimensional — que a aceita como dado ou a rejeita como infundada — é a recusa de ambas as atitudes. A ontologia dimensional capta algo de real. O que capta é a existência, no ser humano, de operações que excedem a capacidade de qualquer

princípio material e que, por essa razão, exigem que a antropologia com que a psiquiatria trabalha inclua uma dimensão que as ciências naturais, pelos seus métodos, não podem abordar. Que Frankl tenha formulado esta exigência com os instrumentos da fenomenologia e da analogia geométrica, e não com os instrumentos da metafísica, explica ao mesmo tempo a fecundidade clínica da sua contribuição — a fenomenologia descreve bem aquilo que a clínica encontra — e a fragilidade filosófica que a acompanha. A descrição é necessária e não é suficiente. A fundação é possível e não foi realizada. O intervalo entre uma coisa e a outra é o intervalo em que o trabalho deste livro se situa.

Há uma passagem de Frankl que, lida à luz de tudo o que foi exposto, adquire uma ressonância que talvez o próprio autor não tenha medido inteiramente. Ao explicar a natureza da autotranscendência — o conceito que será examinado em detalhe adiante e que constitui, com o autodistanciamento, o desdobramento operativo imediato da dimensão noética —, Frankl recorre à imagem do olho:

A autotranscendência assinala o facto antropológico fundamental de que a existência humana está sempre dirigida para algo que não é ela mesma — para algo ou para alguém, isto é, para um sentido a realizar ou para uma existência interpessoal que encontra. Os seres humanos tornam-se genuinamente humanos e são inteiramente eles mesmos apenas quando, elevando-se em devoção a uma tarefa no serviço de uma causa ou por amor a uma outra pessoa, vão além de si mesmos e se esquecem de si mesmos. É análogo ao olho, cuja tarefa de ver o mundo só pode ser realizada na medida em que não pode ver a si mesmo. Pois quando é que o olho vê algo de si mesmo? Apenas quando está doente.

A analogia é de uma exactidão que merece ser retida: o olho que funciona bem é invisível a si mesmo, e a sua invisibilidade a si mesmo é a condição do seu funcionamento. No momento em

que o olho se vê — quando uma opacidade, um corpo flutuante, uma inflamação fazem com que o olho apareça para si mesmo —, o olho está doente, e a doença consiste no facto de que o instrumento, em vez de servir a função para a qual existe, se interpõe entre o sujeito e o mundo. Do mesmo modo, o ser humano que funciona bem — orientado para o sentido, para a tarefa, para o outro — é aquele que se esquece de si mesmo na orientação, e a preocupação excessiva consigo mesmo é, nos termos desta analogia, um sinal de perturbação. A psicologia que se concentra no auto-conhecimento, na auto-estima, na exploração do mundo interior como fins em si mesmos está, nos termos desta analogia, a tratar o olho doente mantendo-o virado para si, quando a cura consistiria em restabelecer a sua transparência — em devolver ao olho a capacidade de ver o mundo sem se ver a si mesmo.

A imagem do olho condensa, com uma economia que nenhum dos argumentos anteriores iguala, a totalidade da posição de Frankl sobre a dimensão noética: o ser humano é constitutivamente orientado para fora de si, e a saúde consiste nessa orientação, e a doença consiste na sua interrupção. A dimensão noética é a dimensão em que essa orientação se constitui — em que o ser humano se dirige ao sentido, ao valor, ao outro — e a sua supressão pelo olhar clínico que a reduz ao psíquico equivale, nos termos da analogia, a causar a doença que se pretendia curar. A ontologia dimensional protege essa orientação ao reconhecê-la como pertencente a uma dimensão própria que nenhuma das outras pode substituir; e o trabalho de fundação que este livro se propõe realizar tem como objectivo último garantir que essa protecção se apoie em algo mais sólido do que uma analogia — por mais certa que a analogia seja.